

米非司酮配伍米索前列醇药物流产的疗效研究

刘 伟

(内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区巴音门克办事处 内蒙古鄂尔多斯 017000)

【摘要】 目的 研究米非司酮配伍米索前列醇进行药物流产的疗效和用药的安全性。方法 用药第一天,早上患者口服米非司酮50mg,用药12小时后再次口服前剂量的一半,第二天用药与第一天相同,两天合计药量为150mg。用药第3天开始配合米索前列醇,剂量为600 μg。观察流产效果。结果 120例患者自身孕囊整体向下排出体外,临床表现为患者平均出血时间为6天左右,21人孕囊在原始位置破裂开,最先将绒毛组织排出,尔后蜕膜逐渐脱落排出体外,平均出血时间为12天;7例口服完米非司酮药物后孕囊自然排出体外,2例无明显药效实施清宫手术。结论 米非司酮配伍米索前列醇进行药物流产,无不良反应,流产成功率高。

【关键词】 流产;米非司酮;米索前列醇;效果

【中图分类号】 R719.3+1

【文献标识码】 B

【文章编号】 1672-2523(2012) 10-0399-01

我院长期根据临床治疗的经验,从米非司酮的用量着手,适当增强抗孕酮药效,以保证患者在药物流产过程中以较短的时间,较少的出血量,实现流产的顺利完成。

1 资料与方法

1.1 临床资料

本组患者均对米非司酮无不良反应,患者年龄在18~42之间,150例发生早孕,平均年龄为24岁,非正常妊娠,停止月经均不到7周。经过B超检查患者孕囊位置,孕囊直径均不超过30mm,患者均没有带器妊娠或异位妊娠。

1.2 方法

用药第一天,早上患者口服米非司酮50mg,用药12小时后再次口服前剂量的一半,第二天用药与第一天相同,两天合计药量为150mg。用药第3天开始配合米索前列醇,剂量为600 μg

2 结果

2.1 治疗结果

120例患者自身孕囊整体向下排出体外,临床表现为患者平均出血时间为6天左右,孕囊在原始位置破裂开,最先将绒毛组织排出,而后蜕膜逐渐脱落排出体外,此类患者21人,前后患者平均出血时间为12天。有7例患者在口服完米非司酮药物后孕囊自然排出体外。有2例患者无明显药效,为患者实施清宫手术结束妊娠。

2.2 副作用

患者用药后产生胃肠道反应或腹痛等症状。腹痛不是很明显,属于孕妇能够承受状态。胃肠道的不适症状属于较轻程度,没有进行特殊处理,病症自行消失。小部分患者服用米索前列醇后,有手心痒、发热、发冷等症状发生,不用做专门处理,症状自动消失。

3 讨论

米非司酮是受体水平抗孕激素的药物,通过与孕激素受体结合拮抗孕酮的生理作用,造成蜕膜细胞变性、坏死、绒毛受损,将胚胎排出。米索前

列醇对各期子宫均有收缩作用,并且还有软化宫颈的作用,二者配伍终止早孕是一种安全有效的方法。

患者在服用米非司酮配伍米索前列醇实施药物流产后,主要问题是易产生阴道长时间流血,导致流血量过多。患者出血量过多的主要原因为绒毛蜕膜组织残留、蜕膜脱落不全、内膜修复不全、宫缩乏力等一系列因素。

在实施人工流产人数中,应尽量避免给患者带来的不良反应。必须在患者实施药物流产前进行B超检查,确认宫内妊娠后,实施相应措施。要求医生向患者认真询问病史,将药物流产所需的注意事项向患者说明,并详细阐明药物流产后可能产生的并发症和不良反应,取得患者同意后,让患者在知情同意书上签字。患者实施药物流产后,要按照医生要求及时留院观察,对于发现的异常反应,有针对性地进行治疗,尽量避免或减少并发症的产生,保证患者的安全。患者在进行药物流产后,务必进行B超检查,一旦发现残留物存在,需进行清宫处理,并适当服用相应的抗生素。

参考文献

- [1] 郭靖.药物流产术与无痛人流术的比较研究[J].中国医药导报,2008,(05).
- [2] 金玲利,钟琴.米索前列醇不同给药方法药物流产效果观察[J].中国乡村医药,2007,(10).
- [3] 杨艳青,程弘夏,钟大放,文爱东.米索前列醇片人体药动学及生物利用度研究[J].中国医院药学杂志,2006,(07).
- [4] 张淑英.药物流产失败的相关因素分析及临床处理[J].中国社区医师(医学专业半月刊),2008,(01).
- [5] 唐爱琴.人工流产术前应用米非司酮扩张宫颈的临床观察[J].中国医药导报,2008,(12).
- [6] 沈文秀.米非司酮联合米索前列醇应用于多次药物流产的观察[J].中国医药导报,2008,(29).

药物相互作用分析及用药安全探讨

王媛媛

(江苏省南京市大厂医院 江苏 南京 210035)

【摘要】 为了在临床实践中提高用药的安全性和有效性,对于药物相互作用的研究不可懈怠。本文对临床治疗中的药物联用进行了简单分析,提倡安全合理用药,尽量规避临床中治疗差错导致的医疗事故。

【关键词】 药物;相互作用;安全用药;分析探讨

【中图分类号】 R971

【文献标识码】 B

【文章编号】 1672-2523(2012) 10-0399-02

药理学(pharmacology)作为研究药物与机体相互作用及其规律和作用机制的一门学科,在医学上具有重要地位。其主要任务包括阐明药物作用机制、改善药物质量、提高药物疗效、开发新药、发现药物新用途^[1],为临床实际操作提供各种数据参考与详细资料。在日常临床中,药物联用作为临床药物治疗的一个重要手段地位突出,医生经常需要面对一次吃几种

甚至是多种药物的患者。为此,药物相互作用分析的研究和用药安全一直以来是我们毫不懈怠关注的重点。

药物相互作用(Drug Interaction,简称DI)是指两种或两种以上的药物同时应用时所发生的药效变化^[1]。根据联合使用药物的不同,会产生协同(增效)、相加(增加)、拮抗(减效)等作用。合理的药物搭配在相互作用下可

以起到增强治疗效果,降低不良反应的效果,反之则会产生拮抗效应,导致临床治疗疗效降低或者毒性增加,甚至发生一些不可测的异常反应,反过来干涉治疗,加重病情,影响医生对病人的救治。所以,如何使药物联用达到效果且保证用药安全,是临床医疗中必须注意的重要问题,而临床医疗中的一些‘配伍禁忌’也是医生们必须注意和熟知的。

1 药物相互作用分析

药物联用在临床治疗中很常见,有些病人服药后病情迅速好转,但也有一些病人出现不良反应病情加重,这都有可能是不同药物之间相互作用的结果。

药物的相互作用主要有良性、不良两大类。

良性作用多表现为协同(synergism),主要有相加作用(additive effect, ummation),增强作用(potentiation),增敏作用(sensitization)[2]。例如阿司匹林与对乙酰氨基酚合用,可使解热镇痛作用相加,这是相加作用的体现;青霉素与丙磺舒合用,能增强青霉素的抗菌作用则是增敏作用的显著效果。虽然良性相互作用的药物联用在临床中值得推崇,但同时也存在一些负面作用,比如链霉素、卡那霉素以及庆大霉素的联合使用,或者先后应用对听神经和肾脏的毒性反应增加,就是在临床治疗中我们应尽量避免的。药物联用有时带来的良性效果虽然蔚为可观,但是在医疗实践中,我们还是提倡 能使用一种药物,就尽量避免两种药物的联用,医生若是选择联用药物,需注意选用良性相互作用的药物,避免因药物使用不当给患者带来痛苦或者造成医疗事故。

药物的不良作用主要表现为拮抗(antagonism),药物的合并使用导致药效减弱,小于它们分别作用的总和。拮抗分别有药理性拮抗(pharmacologic antagonism),生理性拮抗(physiologic antagonism),生化性拮抗(biochemical antagonism),化学性拮抗(chemical antagonism)[2]。例如H1组胺受体拮抗剂苯海拉明可拮抗H1组胺受体激动剂的作用,苯巴比妥能诱导肝微粒体P-450酶系,使保泰松、苯妥英钠的代谢加速,降低其效应等。

以本院曾经出现过的一个病例为案 患者 XXX,67岁,男性,心脏病,慢性肾功能不全。3年来一直服用地高辛治疗心脏病。后因治疗支气管炎,开始服用克拉霉素500mg/d。四天之后,出现虚弱、无力等消化系统症状。心

电图显示窦调律,有轻度的I度房室传导阻滞,右束支阻滞和心肌梗死。血液中地高辛浓度相较入院时增了一倍之多,于是停止服用两种药物,五天后,所有症状减轻,病情得到改善。这种情况就是药物联用所带来的拮抗作用,不仅影响了原本的治疗效果,同时加重了病人的病情,如果不及时停药,控制病情,后果不堪设想。

2 用药安全

随着临床治疗中药物种类的增多以及新品种的不断出现,医生药物联用带来的安全问题越发受到人们的关注,因此,如何做到用药安全与合理用药就显得十万火急。

用药安全的前提首先是药品安全。在对药品进行监督、检测、储藏、使用时都要参照相关规章制度进行严格把关[3],紧抓药品质量,从而保证临床使用中药品的安全与药性。医疗机构需建立和药品安全相关的严格制度,从制度上完善药品的使用与管理,建立一套合理的用药机制。

在用药过程中,医生应该做到安全合理用药。根据不同病人的病情、体质和药物的特性等情况全面分析,真正做到‘对症下药’,注意方法的使用,剂量的控制,同时叮嘱患者药品使用过程中的禁忌。在用药后,应密切观察药物在患者身上产生的效果或副作用,以保证及时排除不良反应,使患者的人身安全得到保障,确保用药安全以及治疗效果,尽量避免用药差错以及不良反应导致的医疗事故。

3 小结

药物相互作用已经成为临床药理学和临床药理学的重要研究对象,在医学界受到了广泛关注,安全合理用药意识也已经深入人心,为社会所关注。作为一名合格的医护人员,在临床工作中,不仅要多了解不同药品的药理特性,同时还要严格规范自己的医疗行为,尽量避免药物联用的不良反应,增强治疗效果,提高临床用药水平。

参考文献

- [1] 药理学[M].清华大学出版社.2012.6.20.
- [2] 弥曼.药理学.第2版.北京人民出版社,2007:22-44
- [3] 郑筱萸,徐玉麟.中华人民共和国药品管理学习辅导[M].中国法制出版社,2001 233

口服庆大霉素注射液治疗急性肠炎的临床效果分析

李弼红

(广东省河源市东源县船塘中心卫生院 广东 河源 517547)

【摘要】 目的 探讨口服庆大霉素注射液在治疗急性肠炎中的临床效果。方法 调节患者的饮食,并口服庆大霉素注射液,患者服下后需留下观察20min,成人每次80mg,小儿酌情减少,观察后未过敏患者则嘱咐其回家后继续口服,早晚各一次,需空腹服用,最后进行电话回访观察效果。结果 所有患者在治疗过程中有1例患者自行中止治疗,其余患者均按照要求服药,治愈的患者中,治疗效果为优的患者有21例,良32例,中6例,差2例,总有效率为96.72%。结论 通过本次研究发现,对急性肠炎患者应用庆大霉素注射液口服治疗的效果良好,治愈率高,值得在临床上推广应用。

【关键词】 庆大霉素注射液;急性肠炎;口服;临床效果

【中图分类号】 R975+3

【文献标识码】 B

【文章编号】 1672-2523(2012) 10-0400-02

急性肠炎是一种常见且多发的病,其主要的临床表现为腹泻、腹痛、腹胀并伴有不同程度的恶心呕吐等。庆大霉素是一种氨基糖苷类抗生素,对各种需氧革兰阴性杆菌都具有很强的抑制活性的作用,其主要的抑制原理是抑制细菌蛋白质的合成,破坏细菌胞浆膜的完整性[1]。

为了研究口服庆大霉素注射液治疗急性肠炎的效果,笔者选取了本院于2010年5月至2012年1月收治的62例急性肠炎患者作为研究对象,进行了疗效分析。现将分析结果报告如下:

1 资料与方法

1.1 临床资料

选取我院于2010年5月至2012年1月收治的62例急性肠炎患者作为研究对象,所有患者均为男性,年龄为10个月~58岁,平均年龄为28.6岁。所有患者中伴有腹痛的有26例,伴有发热的患者有20例,同时伴有腹痛与发热的患者有12例 在患者就诊之前,腹泻时间不足12h的患者有29例,腹泻

24h的患者有21例,腹泻两天以上的患者有12例。所有患者均有饮食不洁或是受凉史,无慢性肠道病史。患者的大便稀薄,部分为水样便,对患者进行常规高倍镜检查发现白细胞较多,未见或是偶见少量白细胞。所有患者在病程中均没有出现水、电解质代谢与酸碱平衡失常的情况。根据患者的病史、症状以及常规的检查我们可以确定,所有患者均为急性细菌性肠炎。

1.2 治疗方法

对患者进行饮食的调节,并进行口服庆大霉素注射液进行治疗。将药瓶安瓿折断后嘱咐患者用吸管服用,成人每次80mg,小儿可以酌情减少,在服用之后留下观察20min,确保患者没有过敏等症状的发生。对于未出现过敏的患者则嘱咐其回家后继续服用药物,服用时间均为早晚饭前各一次,必须空腹服用。最后,对所有患者进行电话回访,了解患者在服药过程中治愈的情况以及有无不良反应等。

1.3 疗效判定